JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, MENTION PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

Raisonnement clinique IPA · Psychiatrie et santé mentale

Un jeu de 52 cartes pour la mention « Psychiatrie et santé mentale ». Chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique, chaque valeur à une situation clinique suivie à travers un même patient. Chaque carte indique les compétences IPA qu'elle mobilise. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données à la coordination du parcours.

Les 4 couleurs = 4 étapes

♥	**Cœur — Recueillir** Anamnèse, écoute, contexte de vie
♦	**Carreau — Repérer & hypothèses** Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges
♣	**Trèfle — Vérifier** Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
♠	**Pique — Agir & suivre** Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Les 13 valeurs = 13 situations

2	Repérage du risque suicidaire
3	Premier épisode psychotique
4	Antipsychotiques et santé métabolique
5	Trouble bipolaire et lithium
6	Dépression : suivi de l'antidépresseur
7	Trouble panique
8	Alcool : sevrage
9	Anorexie mentale : repérage
10	Stress post-traumatique
V	Sujet âgé : confusion
D	Santé somatique en psychiatrie
R	Insomnie et hypnotiques
A	Rétablissement et parcours

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle du lithium »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (antipsychotiques et santé somatique, alcool et TSPT…).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Leadership & recherche** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une situation et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, drapeaux rouges
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : ce qui relève de l'IPA, de la concertation, de l'orientation

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations connues en octobre 2026 (HAS, sociétés savantes, référentiels de la mention), sans vérification en ligne carte par carte ; les cas sont illustratifs. Les conduites thérapeutiques s'entendent dans le cadre des protocoles et de la réglementation en vigueur. À vérifier et actualiser par l'équipe pédagogique avant usage.

MENTION PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

Compétences et situations

La mention psychiatrie et santé mentale couvre le repérage et le suivi des troubles psychiques, la surveillance des traitements psychotropes, la prévention du suicide, la santé somatique des personnes vivant avec un trouble psychique, les addictions et l'accompagnement orienté vers le rétablissement, en lien avec les CMP, les équipes hospitalières et les soins primaires.

Les 6 compétences IPA mobilisées

Code	Compétence	Où dans le jeu
C1	Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées	♥ ♦ ♣
C2	Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé	♣ ♠
C3	Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique	♦ ♠
C4	Organiser les parcours de soins et de santé en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés	♠
C5	Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques en exerçant un leadership clinique	Joker 2, repères ♠
C6	Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques	Joker 2, débriefing

Chaque carte porte en en-tête les compétences qu'elle mobilise en priorité. Les compétences C5 et C6 sont travaillées avec le joker « Leadership & recherche » et lors du débriefing.

Les 13 situations cliniques

2	**Repérage du risque suicidaire** Mme S., 45 ans, suivie pour dépression, vient en consultation : elle a perdu son emploi et dit « ne plus voir d'issue ».
3	**Premier épisode psychotique** Kevin, 20 ans, est amené par ses parents : il s'isole, vit la nuit et dit que ses voisins l'espionnent.
4	**Antipsychotiques et santé métabolique** M. A., 38 ans, schizophrénie stabilisée sous olanzapine depuis 3 ans, vient pour son suivi au CMP.
5	**Trouble bipolaire et lithium** Mme L., 52 ans, trouble bipolaire stabilisé sous lithium depuis 10 ans, a des tremblements et des diarrhées depuis quelques jours.
6	**Dépression : suivi de l'antidépresseur** M. T., 34 ans, a commencé un ISRS il y a 3 semaines pour un épisode dépressif. Il dit que « ça ne marche pas ».
7	**Trouble panique** Mme P., 29 ans, consulte après trois passages aux urgences pour « malaise cardiaque », avec des bilans normaux.
8	**Alcool : sevrage** M. B., 50 ans, demande à arrêter l'alcool. Il boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour depuis des années.
9	**Anorexie mentale : repérage** Chloé, 19 ans, étudiante, est amenée par sa mère pour un amaigrissement important et un arrêt des règles.
10	**Stress post-traumatique** M. D., 41 ans, pompier, consulte 2 mois après une intervention où un enfant est décédé. Il dort mal et évite son travail.
V	**Sujet âgé : confusion** Mme R., 82 ans, en EHPAD, est agitée et désorientée la nuit depuis 2 jours. L'équipe évoque une « démence qui s'aggrave ».
D	**Santé somatique en psychiatrie** M. H., 55 ans, schizophrène, vit en appartement thérapeutique. Il n'a pas de médecin traitant.
R	**Insomnie et hypnotiques** Mme Z., 68 ans, prend un hypnotique chaque soir depuis 6 ans et demande un renouvellement.
A	**Rétablissement et parcours** Mme E., 33 ans, trouble bipolaire, sort d'une hospitalisation pour épisode maniaque. Elle veut reprendre son travail.

2 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Repérage du risque suicidaire

Compétences IPA : C1

> *Mme S., 45 ans, suivie pour dépression, vient en consultation : elle a perdu son emploi et dit « ne plus voir d'issue ».*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Idées suicidaires : fréquence, intensité, scénario, échéance, accès aux moyens
- Antécédents de tentative de suicide, personnels et familiaux
- Facteurs de risque : événement de vie, isolement, alcool
- Facteurs de protection : enfants, soutiens, projets, alliance
- La question posée directement n'augmente pas le risque

Raisonnement clinique · IPA PSM

♠ 2

2 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Repérage du risque suicidaire

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme S., 45 ans, suivie pour dépression, vient en consultation : elle a perdu son emploi et dit « ne plus voir d'issue ».

> *Elle pense au suicide chaque jour et a un scénario, sans échéance fixée.*

? Comment évaluez-vous le niveau de risque ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évaluation RUD : risque, urgence, dangerosité
- Urgence moyenne à élevée : idées quotidiennes, scénario élaboré
- Dangerosité : létalité et accessibilité du moyen envisagé
- Le niveau évalué détermine l'orientation

Raisonnement clinique · IPA PSM

♦ 2

2 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Repérage du risque suicidaire

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme S., 45 ans, suivie pour dépression, vient en consultation : elle a perdu son emploi et dit « ne plus voir d'issue ».

> *Le moyen envisagé est accessible à son domicile.*

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Intensité dépressive, désespoir, impulsivité
- Consommation d'alcool ou de substances
- Symptômes psychotiques
- Soutiens mobilisables dans les 24 à 48 heures

Raisonnement clinique · IPA PSM

♣ 2

2 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Repérage du risque suicidaire

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme S., 45 ans, suivie pour dépression, vient en consultation : elle a perdu son emploi et dit « ne plus voir d'issue ».

> *Elle accepte de l'aide.*

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Urgence élevée : ne pas la laisser seule ; orientation vers les urgences psychiatriques
- Mise à distance des moyens létaux, avec l'entourage
- Plan de sécurité co-construit ; numéro national 3114
- Avis psychiatrique rapide, recontacts programmés (VigilanS après une tentative)
- Traçabilité, transmission à l'équipe

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ 2

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Premier épisode psychotique

Compétences IPA : C1

> *Kevin, 20 ans, est amené par ses parents : il s'isole, vit la nuit et dit que ses voisins l'espionnent.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Idées délirantes, hallucinations, désorganisation, retrait
- Durée de psychose non traitée
- Cannabis et autres substances
- Antécédents psychiatriques familiaux
- Études, relations, autonomie

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Premier épisode psychotique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Kevin, 20 ans, est amené par ses parents : il s'isole, vit la nuit et dit que ses voisins l'espionnent.

> *Symptômes depuis 4 mois ; cannabis quotidien.*

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Premier épisode psychotique
- Trouble psychotique induit par le cannabis à discuter
- Différentiels : cause organique (neurologique, endocrinienne), trouble de l'humeur avec caractéristiques psychotiques
- Risque suicidaire à évaluer

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Premier épisode psychotique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Kevin, 20 ans, est amené par ses parents : il s'isole, vit la nuit et dit que ses voisins l'espionnent.

> *Il accepte un bilan.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen somatique et neurologique
- NFS, ionogramme, glycémie, TSH, bilan hépatique ; toxiques urinaires avec accord
- Imagerie cérébrale selon prescription
- Bilan de référence avant antipsychotique : poids, tour de taille, PA, glycémie, lipides, ECG

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Premier épisode psychotique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Kevin, 20 ans, est amené par ses parents : il s'isole, vit la nuit et dit que ses voisins l'espionnent.

> *Un antipsychotique est prescrit par le psychiatre.*

? Quel accompagnement proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Programme d'intervention précoce, suivi intensif
- Psychoéducation du patient et de la famille
- Réduction du cannabis : entretien motivationnel
- Surveillance de la tolérance et des paramètres métaboliques
- Maintien des études, réhabilitation psychosociale

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

4 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Antipsychotiques et santé métabolique

Compétences IPA : C1

M. A., 38 ans, schizophrénie stabilisée sous olanzapine depuis 3 ans, vient pour son suivi au CMP.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Symptômes, stabilité, adhésion au traitement
- Effets indésirables : poids, sédation, troubles sexuels, symptômes extrapyramidaux
- Tabac, alimentation, activité physique
- Dernier bilan somatique, médecin traitant
- Logement, insertion sociale

♥ 4

Raisonnement clinique · IPA PSM

4 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Antipsychotiques et santé métabolique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. A., 38 ans, schizophrénie stabilisée sous olanzapine depuis 3 ans, vient pour son suivi au CMP.

+ 15 kg en 3 ans, tour de taille 108 cm, 30 cigarettes par jour.

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Syndrome métabolique probable
- Risque cardiovasculaire élevé ; espérance de vie réduite dans les troubles psychiques sévères
- Tabagisme massif
- Retentissement sur l'estime de soi et l'adhésion

♦ 4

Raisonnement clinique · IPA PSM

4 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Antipsychotiques et santé métabolique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. A., 38 ans, schizophrénie stabilisée sous olanzapine depuis 3 ans, vient pour son suivi au CMP.

Pas de bilan sanguin depuis 2 ans.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Glycémie à jeun ou HbA1c, bilan lipidique
- PA, IMC, tour de taille
- ECG (QT)
- Prolactine selon les symptômes

♣ 4

Raisonnement clinique · IPA PSM

4 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Antipsychotiques et santé métabolique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. A., 38 ans, schizophrénie stabilisée sous olanzapine depuis 3 ans, vient pour son suivi au CMP.

Glycémie à jeun 1,18 g/L, triglycérides élevés.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Discuter avec le psychiatre d'une molécule moins métabolique
- Programme alimentation et activité physique adaptée
- Sevrage tabagique avec substituts nicotiniques
- Coordination avec le médecin traitant
- Suivi métabolique régulier

♠ 4

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Trouble bipolaire et lithium

Compétences IPA : C1

Mme L., 52 ans, trouble bipolaire stabilisé sous lithium depuis 10 ans, a des tremblements et des diarrhées depuis quelques jours.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Tremblements, diarrhée, vomissements, confusion, troubles de l'équilibre
- Changements récents : AINS, IEC, diurétique, déshydratation, régime sans sel
- Dernière lithiémie, fonction rénale, TSH
- Humeur actuelle
- Observance, horaires de prise

Raisonnement clinique · IPA PSM

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Trouble bipolaire et lithium

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme L., 52 ans, trouble bipolaire stabilisé sous lithium depuis 10 ans, a des tremblements et des diarrhées depuis quelques jours.

Elle prend un anti-inflammatoire pour une sciatique depuis 5 jours.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Surdosage en lithium probable (interaction avec l'AINS)
- Marge thérapeutique étroite
- Gravité : confusion, ataxie, troubles de la conscience → urgence
- Autre cause de diarrhée à éliminer

Raisonnement clinique · IPA PSM

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Trouble bipolaire et lithium

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme L., 52 ans, trouble bipolaire stabilisé sous lithium depuis 10 ans, a des tremblements et des diarrhées depuis quelques jours.

Pas de confusion.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Lithiémie en urgence (12 h après la dernière prise)
- Créatinine, ionogramme
- ECG
- TSH et calcémie pour le suivi

Raisonnement clinique · IPA PSM

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Trouble bipolaire et lithium

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme L., 52 ans, trouble bipolaire stabilisé sous lithium depuis 10 ans, a des tremblements et des diarrhées depuis quelques jours.

Lithiémie au-dessus de la zone thérapeutique.

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Avis médical urgent : suspension ou adaptation du lithium
- Arrêt de l'AINS
- Hydratation
- ETP : interactions (AINS, IEC, diurétiques), déshydratation, signes de surdosage
- Suivi régulier : lithiémie, fonction rénale, TSH, calcémie

Raisonnement clinique · IPA PSM

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Dépression : suivi de l'antidépresseur

Compétences IPA : C1

M. T., 34 ans, a commencé un ISRS il y a 3 semaines pour un épisode dépressif. Il dit que « ça ne marche pas ».

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évolution des symptômes (PHQ-9 comparé), sommeil, énergie
- Idées suicidaires (vigilance en début de traitement)
- Observance, effets indésirables
- Attentes, compréhension du délai d'action
- Alcool, substances

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Dépression : suivi de l'antidépresseur

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. T., 34 ans, a commencé un ISRS il y a 3 semaines pour un épisode dépressif. Il dit que « ça ne marche pas ».

PHQ-9 de 18 à 15. Nausées et agitation la première semaine ; il a arrêté 3 jours.

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Délai d'action habituel de 2 à 4 semaines ; réponse partielle
- Observance irrégulière liée aux effets indésirables initiaux
- Agitation en début de traitement : vigilance suicidaire
- Trop tôt pour conclure à l'inefficacité

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Dépression : suivi de l'antidépresseur

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. T., 34 ans, a commencé un ISRS il y a 3 semaines pour un épisode dépressif. Il dit que « ça ne marche pas ».

Pas d'idée suicidaire actuelle.

? Que recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Virage de l'humeur (symptômes hypomaniaques)
- Comorbidité anxieuse, alcool
- Facteurs de maintien : conflits, travail
- PHQ-9 répétés

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Dépression : suivi de l'antidépresseur

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. T., 34 ans, a commencé un ISRS il y a 3 semaines pour un épisode dépressif. Il dit que « ça ne marche pas ».

Il accepte de poursuivre.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Information sur le délai d'action et les effets transitoires
- Poursuite, réévaluation à 4–6 semaines avec le médecin
- Psychothérapie associée
- Activité physique, rythmes de vie
- Traitement poursuivi 6 mois à 1 an après la rémission

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Trouble panique

Compétences IPA : C1

Mme P., 29 ans, consulte après trois passages aux urgences pour « malaise cardiaque », avec des bilans normaux.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Crises : palpitations, dyspnée, peur de mourir, durée
- Fréquence, déclencheurs, anxiété anticipatoire
- Évitements : transports, lieux publics
- Caféine, substances, médicaments
- Retentissement social et professionnel

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ 7

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Trouble panique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme P., 29 ans, consulte après trois passages aux urgences pour « malaise cardiaque », avec des bilans normaux.

Crises brutales de 10 minutes, peur intense d'en refaire ; elle ne prend plus le métro.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Trouble panique avec agoraphobie
- Différentiels : hyperthyroïdie, trouble du rythme, substances
- Comorbidité dépressive fréquente
- Risque de recours prolongé aux anxiolytiques

Raisonnement clinique · IPA PSM

♦ 7

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Trouble panique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme P., 29 ans, consulte après trois passages aux urgences pour « malaise cardiaque », avec des bilans normaux.

Les bilans cardiaques sont normaux.

? Quels examens complètent votre évaluation ?

REPÈRES ATTENDUS

- TSH, glycémie
- Relire avec elle les résultats déjà obtenus
- Échelles : GAD-7, sévérité du trouble panique
- Évaluation de l'humeur

Raisonnement clinique · IPA PSM

♣ 7

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Trouble panique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme P., 29 ans, consulte après trois passages aux urgences pour « malaise cardiaque », avec des bilans normaux.

Elle veut « reprendre le métro ».

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Psychoéducation : mécanisme de la crise
- TCC avec exposition progressive
- Respiration, relaxation
- ISRS si besoin, sur prescription ; éviter les benzodiazépines au long cours
- Suivi et réévaluation

Raisonnement clinique · IPA PSM

♠ 7

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Alcool : sevrage

Compétences IPA : C1

> *M. B., 50 ans, demande à arrêter l'alcool. Il boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour depuis des années.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Consommation, horaires, besoin matinal
- Antécédents de sevrage compliqué (convulsions, delirium tremens)
- Comorbidités hépatiques et psychiatriques, autres substances
- Contexte social, entourage
- Motivation, objectifs

♥ 8

Raisonnement clinique · IPA PSM

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Alcool : sevrage

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. B., 50 ans, demande à arrêter l'alcool. Il boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour depuis des années.

> *Tremblements matinaux ; une crise convulsive lors d'un arrêt il y a 2 ans.*

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dépendance sévère
- Risque de sevrage compliqué : antécédent de convulsion
- Sevrage ambulatoire déconseillé : sevrage hospitalier
- Carence en vitamine B1 : risque d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke

♦ 8

Raisonnement clinique · IPA PSM

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Alcool : sevrage

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. B., 50 ans, demande à arrêter l'alcool. Il boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour depuis des années.

> *Il accepte un bilan.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Bilan hépatique, GGT, NFS (VGM, plaquettes), TP
- Ionogramme, glycémie
- Humeur, risque suicidaire
- Score de Cushman pour suivre le sevrage

♣ 8

Raisonnement clinique · IPA PSM

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Alcool : sevrage

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. B., 50 ans, demande à arrêter l'alcool. Il boit l'équivalent d'une bouteille de whisky par jour depuis des années.

> *Un sevrage hospitalier est programmé.*

? Quel accompagnement proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Sevrage encadré : benzodiazépines selon protocole, vitamine B1, hydratation
- Suivi addictologique après le sevrage (CSAPA)
- Traitement d'aide au maintien de l'abstinence, sur prescription
- Groupes d'entraide, entourage
- Prévention de la rechute

♠ 8

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Anorexie mentale : repérage

Compétences IPA : C1

Chloé, 19 ans, étudiante, est amenée par sa mère pour un amaigrissement important et un arrêt des règles.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Histoire pondérale, IMC
- Comportements alimentaires, activité physique
- Perception du corps, peur de grossir
- Aménorrhée, fatigue, frilosité, malaises
- Humeur, anxiété, isolement

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ 6

9 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Anorexie mentale : repérage

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Chloé, 19 ans, étudiante, est amenée par sa mère pour un amaigrissement important et un arrêt des règles.

IMC 15,5 kg/m², restriction sévère, activité physique intense.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Anorexie mentale probable
- Questionnaire de repérage SCOFF
- Gravité somatique et psychiatrique à évaluer
- Différentiels : maladie cœliaque, hyperthyroïdie, diabète

Raisonnement clinique · IPA PSM

♦ 6

9 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Anorexie mentale : repérage

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Chloé, 19 ans, étudiante, est amenée par sa mère pour un amaigrissement important et un arrêt des règles.

Vous évaluez la gravité.

? Quels éléments recherchez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- FC, PA, température, malaises
- Kaliémie, phosphorémie, glycémie, ECG
- Rapidité de la perte de poids
- Risque suicidaire

Raisonnement clinique · IPA PSM

♣ 6

9 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Anorexie mentale : repérage

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Chloé, 19 ans, étudiante, est amenée par sa mère pour un amaigrissement important et un arrêt des règles.

FC à 42/min.

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Signe de gravité : avis spécialisé urgent, hospitalisation à discuter
- Orientation vers une équipe spécialisée
- Alliance avec la patiente et sa famille
- Renutrition encadrée (risque de syndrome de renutrition)
- Suivi pluridisciplinaire

Raisonnement clinique · IPA PSM

♠ 6

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

10 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Stress post-traumatique

Compétences IPA : C1

M. D., 41 ans, pompier, consulte 2 mois après une intervention où un enfant est décédé. Il dort mal et évite son travail.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Reviviscences : cauchemars, flash-backs
- Évitement, hypervigilance, irritabilité
- Humeur, culpabilité, idées suicidaires
- Alcool, médicaments
- Soutiens professionnels et familiaux

Raisonnement clinique · IPA PSM

10 ♥

10 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Stress post-traumatique

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. D., 41 ans, pompier, consulte 2 mois après une intervention où un enfant est décédé. Il dort mal et évite son travail.

Symptômes quotidiens depuis 2 mois ; consommation d'alcool en hausse.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Trouble de stress post-traumatique (symptômes > 1 mois)
- Échelle PCL-5
- Comorbidités : dépression, trouble de l'usage d'alcool
- Risque suicidaire

Raisonnement clinique · IPA PSM

10 ♦

10 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Stress post-traumatique

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. D., 41 ans, pompier, consulte 2 mois après une intervention où un enfant est décédé. Il dort mal et évite son travail.

Il craint le regard de ses collègues.

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Risque suicidaire
- AUDIT
- Retentissement fonctionnel
- Antécédents traumatiques

Raisonnement clinique · IPA PSM

10 ♣

10 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Stress post-traumatique

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. D., 41 ans, pompier, consulte 2 mois après une intervention où un enfant est décédé. Il dort mal et évite son travail.

Il accepte une prise en charge.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Psychothérapie centrée sur le trauma (TCC, EMDR)
- Prise en charge de l'alcool
- Lien avec la santé au travail
- Sommeil : mesures non médicamenteuses
- Suivi régulier

Raisonnement clinique · IPA PSM

10 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Sujet âgé : confusion

Compétences IPA : C1

> *Mme R., 82 ans, en EHPAD, est agitée et désorientée la nuit depuis 2 jours. L'équipe évoque une « démence qui s'aggrave ».*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Début brutal ou progressif, fluctuations
- Nouveau médicament, fièvre, douleur, constipation, rétention urinaire
- Hydratation, alimentation
- État cognitif antérieur
- Sommeil, changement d'environnement

Raisonnement clinique · IPA PSM

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Sujet âgé : confusion

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme R., 82 ans, en EHPAD, est agitée et désorientée la nuit depuis 2 jours. L'équipe évoque une « démence qui s'aggrave ».

> *Début brutal, fluctuations, inattention.*

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Syndrome confusionnel (CAM positive)
- Urgence : rechercher une cause somatique
- Ne pas conclure à une aggravation de la démence
- Différentiels : dépression, évolution d'un trouble neurocognitif

Raisonnement clinique · IPA PSM

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Sujet âgé : confusion

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme R., 82 ans, en EHPAD, est agitée et désorientée la nuit depuis 2 jours. L'équipe évoque une « démence qui s'aggrave ».

> *Vous cherchez la cause.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Constantes, glycémie capillaire
- Globe urinaire, fécalome, douleur
- Ionogramme, calcémie, NFS, CRP, ECBU
- Revue des médicaments (anticholinergiques, benzodiazépines)

Raisonnement clinique · IPA PSM

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Sujet âgé : confusion

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme R., 82 ans, en EHPAD, est agitée et désorientée la nuit depuis 2 jours. L'équipe évoque une « démence qui s'aggrave ».

> *Une rétention urinaire est retrouvée.*

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Traitement de la cause (sondage, recherche d'infection)
- Mesures non médicamenteuses : orientation, présence, lunettes et appareils auditifs
- Éviter contention et sédatifs
- Révision des médicaments
- Protocole de repérage de la confusion pour l'équipe

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Santé somatique en psychiatrie

Compétences IPA : C1

M. H., 55 ans, schizophrène, vit en appartement thérapeutique. Il n'a pas de médecin traitant.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antécédents somatiques, dernier bilan
- Tabac, alimentation, activité
- Santé bucco-dentaire
- Dépistages, vaccinations
- Douleur (expression souvent atypique)

Raisonnement clinique · IPA PSM

D ♥

D ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Santé somatique en psychiatrie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. H., 55 ans, schizophrène, vit en appartement thérapeutique. Il n'a pas de médecin traitant.

Il fume, a mal aux dents et n'a jamais fait de dépistage.

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Surmortalité somatique des personnes ayant un trouble psychique sévère
- Retards de dépistage et de soins
- Risques cardiovasculaire, respiratoire, dentaire
- Obstacles à l'accès aux soins

Raisonnement clinique · IPA PSM

D ♦

D ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Santé somatique en psychiatrie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. H., 55 ans, schizophrène, vit en appartement thérapeutique. Il n'a pas de médecin traitant.

Vous préparez un bilan.

? Quel bilan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen somatique complet, PA, IMC
- Glycémie, lipides
- Dépistages organisés selon l'âge
- ECG, consultation dentaire

Raisonnement clinique · IPA PSM

D ♣

D ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Santé somatique en psychiatrie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. H., 55 ans, schizophrène, vit en appartement thérapeutique. Il n'a pas de médecin traitant.

M. H. accepte d'être accompagné.

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Recherche d'un médecin traitant
- Accompagnement physique aux rendez-vous
- Sevrage tabagique adapté
- Coordination psychiatrie et soins primaires
- Indicateurs de suivi somatique du service

Raisonnement clinique · IPA PSM

D ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Insomnie et hypnotiques

Compétences IPA : C1

> *Mme Z., 68 ans, prend un hypnotique chaque soir depuis 6 ans et demande un renouvellement.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Plainte : endormissement, réveils, durée du sommeil
- Habitudes, siestes
- Durée et dose de l'hypnotique, effet ressenti
- Chutes, mémoire, somnolence diurne
- Anxiété, dépression

R ♥

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Insomnie et hypnotiques

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme Z., 68 ans, prend un hypnotique chaque soir depuis 6 ans et demande un renouvellement.

> *Deux chutes. Elle a peur de « ne plus dormir du tout » sans son comprimé.*

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Usage prolongé, dépendance
- Risques : chutes, troubles cognitifs, accidents
- Insomnie chronique non traitée en tant que telle
- Anxiété liée à l'arrêt

R ♦

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Insomnie et hypnotiques

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme Z., 68 ans, prend un hypnotique chaque soir depuis 6 ans et demande un renouvellement.

> *Vous complétez l'évaluation.*

? Quelles évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Agenda du sommeil
- Apnées du sommeil, jambes sans repos
- Humeur
- Risque de chute

R ♣

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Insomnie et hypnotiques

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme Z., 68 ans, prend un hypnotique chaque soir depuis 6 ans et demande un renouvellement.

> *Elle accepte d'essayer de réduire.*

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Décroissance progressive sur plusieurs semaines, avec le prescripteur
- TCC de l'insomnie
- Hygiène du sommeil, restriction du temps passé au lit
- Information sur l'effet rebond transitoire
- Suivi régulier

R ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Rétablissement et parcours

Compétences IPA : C1

Mme E., 33 ans, trouble bipolaire, sort d'une hospitalisation pour épisode maniaque. Elle veut reprendre son travail.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Compréhension de la maladie, signes précurseurs
- Traitement, adhésion, effets indésirables
- Entourage, logement, travail
- Projets, priorités
- Soutiens professionnels

Raisonnement clinique · IPA PSM

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Rétablissement et parcours

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme E., 33 ans, trouble bipolaire, sort d'une hospitalisation pour épisode maniaque. Elle veut reprendre son travail.

Elle a arrêté son traitement deux fois en un an.

? Quels besoins identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Psychoéducation
- Plan de crise, directives anticipées en psychiatrie
- Soutien à l'insertion professionnelle
- Approche orientée rétablissement

Raisonnement clinique · IPA PSM

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Rétablissement et parcours

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme E., 33 ans, trouble bipolaire, sort d'une hospitalisation pour épisode maniaque. Elle veut reprendre son travail.

Elle exprime des réticences au traitement.

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Freins à l'adhésion
- Fonctionnement et cognition
- Besoins sociaux
- Humeur

Raisonnement clinique · IPA PSM

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Rétablissement et parcours

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme E., 33 ans, trouble bipolaire, sort d'une hospitalisation pour épisode maniaque. Elle veut reprendre son travail.

Elle souhaite être actrice de son parcours.

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Plan de crise conjoint, directives anticipées en psychiatrie
- Psychoéducation, pair-aidance
- Réhabilitation psychosociale, emploi accompagné
- Coordination CMP, médecin traitant, services sociaux
- Évaluation des résultats avec la patiente

Raisonnement clinique · IPA PSM

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

Drapeau rouge

Choisissez une situation du jeu et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

Leadership & recherche

À partir de la dernière situation jouée, proposez une action d'amélioration des pratiques (protocole, audit, formation) ou formulez une question de recherche (PICO).

Compétences C5 · C6. Si le groupe valide, ce joker remplace une carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

♥ **Cœur · Recueillir**
Anamnèse, écoute, contexte de vie

♦ **Carreau · Repérer & hypothèses**
Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges

♣ **Trèfle · Vérifier**
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

♠ **Pique · Agir & suivre**
Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Repérage du risque suicidaire
3	Premier épisode psychotique
4	Antipsychotiques et santé métabolique
5	Trouble bipolaire et lithium
6	Dépression : suivi de l'antidépresseur
7	Trouble panique
8	Alcool : sevrage
9	Anorexie mentale : repérage
10	Stress post-traumatique
V	Sujet âgé : confusion
D	Santé somatique en psychiatrie
R	Insomnie et hypnotiques
A	Rétablissement et parcours

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · PSM

IPA · Master